

CARDIOLOGIE & CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE

Fiches QE Haute Fréquence — Pathologie cardiovasculaire S6 — Version 1

Cross-match : 750 QEs officielles (Mai 2019 → Ratt 2025) × Cours AIO Cardio-Ccv (cardio-aio.pdf)

FMPM — Pathologie cardiovasculaire S6 — Concours 2026

PARTIE 1 — CLASSEMENT DES LEÇONS PAR ORDRE D'IMPORTANCE

Classement basé sur la fréquence réelle dans 750 QEs (15 sessions).

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
1	HTA	68 Q	Médecine
2	Troubles du rythme + conduction + Fibrillation atriale	57 Q	Médecine
3	Cardiopathies congénitales	54 Q	Médecine
4	Insuffisance cardiaque (+ cardiomyopathies)	52 Q	Médecine
5	Risque cardiovasculaire	42 Q	Médecine
6	SCA ST+	39 Q	Médecine
7	Maladie veineuse thrombo-embolique (TVP/EP)	37 Q	Médecine
8	Athérosclérose	32 Q	Médecine
9	Rhumatisme articulaire aigu	30 Q	Médecine
10	Angor chronique stable (SCC)	30 Q	Médecine
11	Maladie du péricarde (aiguë + constrictive + tamponnade)	30 Q	Médecine
12	Endocardites infectieuses	26 Q	Médecine
13	Prothèses valvulaires cardiaques	26 Q	Chirurgie
14	Anévrisme de l'aorte abdominale	25 Q	Chirurgie
15	AOMI	24 Q	Chirurgie
16	Dissection de l'aorte	24 Q	Chirurgie
17	Insuffisance mitrale	22 Q	Médecine
18	Varices des membres inférieurs	18 Q	Chirurgie
19	SCA ST-	17 Q	Médecine
20	Ischémie aiguë des membres inférieurs	17 Q	Chirurgie
21	Coarctation aortique	17 Q	Chirurgie
22	Insuffisance aortique	16 Q	Médecine
23	Rétrécissement aortique	15 Q	Médecine
24	Rétrécissement mitral	12 Q	Médecine

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
25	HTAP / Hypertension pulmonaire	11 Q	Médecine
26	Syncope	8 Q	Médecine

PARTIE 2 — MOYENNE DE QUESTIONS PAR LEÇON PAR EXAMEN

Statistiques calculées sur 15 sessions, chaque examen ~50 questions.

Leçon officielle	Total	Moy/exam	% d'exam
HTA	68	4.53	9.1%
Troubles du rythme + conduction + Fibrillation atriale	57	3.80	7.6%
Cardiopathies congénitales	54	3.60	7.2%
Insuffisance cardiaque (+ cardiomyopathies)	52	3.47	6.9%
Risque cardiovasculaire	42	2.80	5.6%
SCA ST+	39	2.60	5.2%
Maladie veineuse thrombo-embolique (TVP/EP)	37	2.47	4.9%
Athérosclérose	32	2.13	4.3%
Rhumatisme articulaire aigu	30	2.00	4.0%
Angor chronique stable (SCC)	30	2.00	4.0%
Maladie du péricarde (aiguë + constrictive + tamponnade)	30	2.00	4.0%
Endocardites infectieuses	26	1.73	3.5%
Prothèses valvulaires cardiaques	26	1.73	3.5%
Anévrisme de l'aorte abdominale	25	1.67	3.3%
AOMI	24	1.60	3.2%
Dissection de l'aorte	24	1.60	3.2%
Insuffisance mitrale	22	1.47	2.9%
Varices des membres inférieurs	18	1.20	2.4%
SCA ST-	17	1.13	2.3%
Ischémie aiguë des membres inférieurs	17	1.13	2.3%
Coarctation aortique	17	1.13	2.3%
Insuffisance aortique	16	1.07	2.1%
Rétrécissement aortique	15	1.00	2.0%
Rétrécissement mitral	12	0.80	1.6%
HTAP / Hypertension pulmonaire	11	0.73	1.5%
Syncope	8	0.53	1.1%
TOTAL leçons officielles (PARTIE 4 vide — voir disclaimer)	749 Q	49.9	≈100%

PARTIE 3 — QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES (ORDRE STRICT PAR RANG)

Format : faits (-) / pièges (Δ) / source (□) / lien cours (□) / citations (□)

[RANG 1] HTA

— • ~4.53 Q/examen

Définitions des grades (au cabinet, mmHg) :

- Normale haute / préhypertension : 130–139 / 85–89
- Grade 1 : 140–159 / 90–99
- Grade 2 : 160–179 / 100–109
- Grade 3 : ≥ 180 / ≥ 110
- Δ Δ Grade 2 confondu avec $\geq 140/80$ — c'est 160–179/100–109
- Δ Δ « Normale haute » n'impose PAS de traitement pharmacologique si RCV faible

□ Vu : Mai2024 Q27, Juin2024 Q27, Nov2024 Q27, Mai2023 Q33, Déc2024 Q27 (très répété)

Seuils HORS cabinet (le piège le plus fréquent) :

- Automesure / MAPA diurne : $\geq 135/85$
- MAPA sur 24 h : $\geq 130/80$
- MAPA nocturne : $\geq 120/70$
- HTA masquée = normale au cabinet mais $\geq 135/85$ en ambulatoire ; HTA blouse blanche = élevée au cabinet, normale en ambulatoire
- Δ Δ Ne pas appliquer le seuil 140/90 (cabinet) aux mesures ambulatoires
- Δ Δ HTA blouse blanche = PAS de traitement d'emblée (juste surveillance)

□ Vu : Mai2022 Q29, Mai2021 Q29, Juin2021 Q29-30, Mai2020 Q5, Juin2019 Q5, Mai19 Q22

Confirmation diagnostique :

- Repose sur des mesures répétées sur plusieurs consultations OU le recours à la mesure ambulatoire (MAPA/automesure)
- Brassard adapté à la circonférence du bras
- Δ Δ Une seule consultation ne suffit JAMAIS
- Δ Δ L'hérédité familiale ou une PAS très élevée ne dispensent pas de confirmer

□ Vu : $\geq 10\times$ (Mai2024 Q29, Juin2024 Q29, Nov2024 Q29, Mai2022 Q31, Mai19 Q23...)

HTA comme facteur de risque & traitement :

- FdR cardiovasculaire MAJEUR, MODIFIABLE et QUANTITATIF (relation dose-effet)
- Bithérapie d'emblée à faible dose le plus souvent (sujet à RCV élevé / grade ≥ 2)
- HTA résistante = non contrôlée sous trithérapie à doses optimales incluant un diurétique → confirmer par MAPA, ajouter un diurétique distal (spironolactone) ou bêtabloquant
- Sténose bilatérale des artères rénales → éviter les IEC ; IEC → surveiller la fonction rénale (kaliémie/créat)
- Δ Δ « Qualitatif » et « non modifiable » sont les faux classiques
- Δ Δ Diurétiques thiazidiques à éviter si goutte/hyperuricémie

□ Vu : Mai2024 Q39, Mai2023 Q32, Juin2021 Q34, Juin2020 Q6-7, Mai2020 Q14, Juin19 Q14

Retentissement & bilan :

- HVG à l'ECG : onde S profonde en V1 + onde R ample en V5-V6 ; indice de Cornell / Sokolow
- Atteinte rénale médiée : ratio albuminurie/créatininurie > 30 mg/g
- Urgence hypertensive = HTA sévère AVEC retentissement viscéral aigu (pas un simple chiffre)
- Δ Δ HVG ≠ onde Q de nécrose ni onde R en D1
- Δ Δ Grade 3 sans retentissement viscéral n'est pas une urgence hypertensive

□ Vu : Juin2024 Q33, Nov2024 Q33, Mai2023 Q38, Juin2025 Q28-29, Mai2020 Q12

[RANG 2] TROUBLES DU RYTHME, DE CONDUCTION & FIBRILLATION ATRIALE

— • ~3.80 Q/examen

Blocs auriculo-ventriculaires (ECG) :

- BAV 1 : PR allongé constant > 200 ms (0,20 s)
- BAV 2 Mobitz I (Luciani-Wenckebach) : allongement PROGRESSIF du PR jusqu'à une onde P bloquée
- BAV 3 (complet) : dissociation auriculo-ventriculaire complète
- Syncope d'Adams-Stokes = perte de connaissance à l'emporte-pièce (sans prodrome)
- ⚠️ *Ne pas confondre Mobitz I (PR progressif) et BAV complet (dissociation)*
- ⚠️ *Bradycardie 30 bpm + syncope = BAV complet, pas bradycardie sinusale*

□ Vu : Mai2023 Q26, Juin2023 Q26, Mai2021 Q6, Juin2021 Q8, Mai2020 Q20-21

Indication / type de stimulation :

- BAV complet dégénératif symptomatique → pacemaker double chambre DÉFINITIF
- BAV complet RÉVERSIBLE (hyperkaliémie sur dialyse manquée, intoxication BB/amiodarone) → stimulation provisoire (SEES) + traiter la cause (hémodialyse, mesures hypokaliémiantes) — PAS de pacemaker définitif
- ⚠️ *BAV 1° asymptomatique → AUCUN pacemaker*
- ⚠️ *Cause réversible ⇒ jamais de pacemaker définitif d'emblée*

□ Vu : Mai2024 Q24-25, Juin2024 Q24-25, Nov2024 Q24-25, Ratt2025 Q26

Anticoagulation de la FA (CHA₂ DS₂ -VASc) :

- FA NON valvulaire → AOD en 1ère intention (apixaban, rivaroxaban)
- FA VALVULAIRE (rétrécissement mitral, prothèse mécanique) → AVK obligatoire (AOD contre-indiqués)
- CHA₂ DS₂ -VASc = 0 (cœur sain, sujet jeune) → AUCUNE anticoagulation
- Avant cardioversion : ETO sans thrombus auriculaire OU anticoagulation efficace (INR 2-3) ≥ 3 semaines
- ⚠️ *Antiagrégants (aspirine/clopidogrel) n'ont PAS de place dans la prévention embolique de la FA*
- ⚠️ *clé discutable : « AVK contre-indiqué si DFG<30 » est faux — les AVK restent utilisables ; ce sont les AOD qui sont prudents en IRC sévère*

□ Vu : Mai2023 Q24, Mai2024 Q26, Juin2024 Q26, Mai2021 Q7, Juin2021 Q10, Mai2020 Q23

Ralentir vs cardioverser / flutter :

- Ralentissement : bêtabloquant ; amiodarone (cordarone) si FEVG altérée
- Restauration du rythme : flécaïne si FEVG conservée et cœur sain ; amiodarone si cardiopathie/FEVG altérée
- FA + choc (état de choc, FA rapide) → cardioversion électrique synchronisée en urgence
- Flutter atrial : macro-réentrée auriculaire, ondes à ~300/min en DII-DIII-aVF, ablation par radiofréquence dans la forme typique ; complications thrombo-emboliques
- ⚠️ *Flécaïne CONTRE-INDIQUÉE si cardiopathie ischémique / FEVG altérée*
- ⚠️ *Flutter n'a PAS d'onde delta (≠ pré-excitation) et n'est pas ventriculaire*

□ Vu : Nov2024 Q26, Déc2024 Q26, Mai2021 Q9, Juin2021 Q11, Mai2023 Q25, Juin2023 Q25

[RANG 3] CARDIOPATHIES CONGÉNITALES

— • ~3.60 Q/examen

Tétralogie de Fallot (cyanogène, la + fréquente) :

- 4 éléments : CIV + sténose pulmonaire + aorte à cheval + HVD
- Squatting (accroupissement) et malaise anoxique (perte de connaissance avec MAJORATION de la cyanose + tachycardie) sont caractéristiques
- Radio : cœur « en sabot »

- **⚠️ ⚠️ Piège constant** : c'est CIV (pas CIA) et sténose PULMONAIRE (pas aortique)
- **⚠️ ⚠️ Malaise anoxique** = cyanose qui AUGMENTE (pas qui disparaît), avec tachycardie

□ Vu : Mai2024 Q13, Juin2024 Q13, Nov2024 Q13, Mai2020 Q38-39, Juin2023 Q14 (très répété)

Transposition des gros vaisseaux (D-TGV) :

- Radio : cœur « en œuf » couché ; nouveau-né cyanosé (SaO₂ basse ~76 %)
- TGV + CIV/CIA large → cure totale (switch artériel) d'emblée
- TGV ISOLÉE (septum intact) → Rashkind (atrioseptostomie) EN URGENCE ± prostaglandine pour maintenir le canal artériel ouvert
- **⚠️ ⚠️ Distinguer TGV + CIV large (cure d'emblée) vs TGV isolée (Rashkind urgent)**
- **⚠️ ⚠️ Blalock-Taussig** = palliatif des cardiopathies à débit pulmonaire diminué (Fallot), pas la TGV

□ Vu : Mai2024 Q14, Juin2024 Q14, Mai2021 Q26, Juin2021 Q26, Mai2023 Q13

Shunts gauche-droite (CIA, CIV, PCA) :

- CIA : dilatation des cavités DROITES ; ECG = HAD + HVD (souvent BBD incomplet)
- CIV large : souffle systolique au 4e EIC gauche en rayon de roue ; risque d'HTAP/Eisenmenger ; cerclage de l'AP si non opérable d'emblée
- PCA (canal artériel) : souffle CONTINU sous-claviculaire gauche
- Complication commune des shunts G-D larges : HTAP (Eisenmenger) + dilatation cavitaire
- **⚠️ ⚠️ CIA → cavités DROITES (HVG/HAG sur l'ECG = incompatible avec CIA)**
- **⚠️ ⚠️ Souffle CONTINU = PCA ; rayon de roue 4e EICG = CIV ; ne pas inverser**

□ Vu : Juin2024 Q11-12, Nov2024 Q11-12, Mai2020 Q36-37, Mai2022 Q13-14, Juin2021 Q28

[RANG 4] INSUFFISANCE CARDIAQUE (+ CARDIOMYOPATHIES)

— • ~3.47 Q/examen

Classification par FEVG :

- IC à FE ALTÉRÉE (systolique) : FEVG < 40 %
- IC à FE préservée (diastolique) : FEVG > 50 % (altération exclusive de la fonction diastolique) — fréquente chez le sujet âgé, HTA, SAOS
- Stades AHA : A = à risque (pas encore d'IC), ... D = avancée
- **⚠️ ⚠️ FE préservée n'est pas « rare » et ne prédomine pas chez le sujet jeune**
- **⚠️ ⚠️ Stade A = situation à RISQUE, pas une IC décompensée**

□ Vu : Mai2022 Q36-37, Mai2021 Q37, Juin2021 Q37, Mai2020 Q8, Mai2023 Q35

Diagnostic positif :

- Triade : dyspnée d'effort + anomalie fonction systolique OU diastolique + élévation du (Pro)BNP
- Signes de forte probabilité : bruit de galop, crépitations, turgescence jugulaire + reflux hépato-jugulaire (= congestif)
- NYHA II = dyspnée à la montée de ≥ 2 étages
- **⚠️ ⚠️ Un BNP/ProBNP normal rend l'IC peu probable**
- **⚠️ ⚠️ Crépitations unilatéraux ou OMI isolés sans RHJ ne suffisent pas**

□ Vu : Nov2024 Q34, Mai2020 Q10, Juin2023 Q36, Mai2023 Q36, Juin2020 Q10

Traitement — congestion vs pronostic :

- Congestion (PA normale) : diurétiques de l'ANSE (furosémide)
- Traitement à visée PRONOSTIQUE (FE altérée) : bloqueurs SRA (IEC/ARA/ARNI) + bêtabloquants (± anti-aldostérone, iSGLT2)
- IC systolique + BBG complet + FEVG basse → resynchronisation (pacemaker TRIPLE chambre / CRT ± défibrillateur)
- **⚠️ ⚠️ Diurétiques et digoxine soulagent mais n'améliorent PAS le pronostic**
- **⚠️ ⚠️ Inhibiteurs calciques (non dihydropyridines) délétères dans l'IC systolique**

□ Vu : Juin2024 Q36/Q40, Nov2024 Q36/Q40, Juin2023 Q37, Juin2020 Q13, Mai2023 Q37/Q39

Facteurs pronostiques :

- Mauvais pronostic : hyponatrémie marquée, BBG complet, pic VO₂ bas, ProBNP élevé
- Congestion pulmonaire = pression capillaire pulmonaire ÉLEVÉE
- ⚠️ ⚠️ *Hyponatrémie (pas hypercalcémie/hypomagnésémie) est le marqueur recherché*

□ Vu : Mai2020 Q13, Mai2023 Q39, Juin2023 Q39, Mai2021 Q38, Juin2021 Q38

[RANG 5] RISQUE CARDIOVASCULAIRE

— • ~2.80 Q/examen

Score SCORE2 :

- Évalue la morbi-mortalité CV à 10 ans, chez l'homme ET la femme (40–69 ans)
- Composantes : âge, sexe, tabac, PA systolique, cholestérol NON-HDL
- Ne s'applique pas au diabétique ni au patient en prévention secondaire (déjà à haut/très haut risque)
- ⚠️ ⚠️ *SCORE2 = morbi-MORTALITÉ (pas mortalité seule) ; n'inclut pas le score calcique ni l'âge <40 ans*
- ⚠️ ⚠️ *Cholestérol NON-HDL (pas le cholestérol total ni les triglycérides)*

□ Vu : Mai2024 Q37-38, Juin2024 Q37-38, Nov2024 Q37-38, Mai2022 Q39-40, Juin2025 Q38

Stratification (catégories à reconnaître d'emblée) :

- TRÈS élevé : maladie CV documentée (coronarien, AOMI, sténose carotidienne), diabète + atteinte d'organe/protéinurie
- ÉLEVÉ : diabétique avec IRC modérée (stade 3), HTA grade 3, hypercholestérolémie familiale
- Patient coronarien / artéritique = très élevé → recherche systématique des autres localisations athéromateuses
- ⚠️ ⚠️ *Un patient à maladie CV avérée ne se « calcule » pas par SCORE2 — il est d'emblée (très) élevé*
- ⚠️ ⚠️ *Score de Genève = embolie pulmonaire, PAS le RCV*

□ Vu : Juin2024 Q39, Nov2024 Q39, Mai2024 Q30, Juin2023 Q28, Mai19 Q27

[RANG 6] SCA ST+ (IDM avec sus-décalage)

— • ~2.60 Q/examen

Diagnostic ECG (topographie) :

- Mécanisme : occlusion COMPLÈTE d'une coronaire par thrombose
- Antérieur : V1–V6 ; Inférieur : DII-DIII-aVF ; Latéral : DI-aVL (haut) / V5-V6 ; Postérieur (VD/basal) : V7-V9
- Douleur constrictive de repos prolongée + sus-décalage persistant
- ⚠️ ⚠️ *Occlusion PARTIELLE / sub-occlusive = SCA ST- (pas ST+)*

□ Vu : Juin2025 Q19-20, Mai2024 Q19, Juin2024 Q20, Nov2024 Q19, Mai2023 Q20

Reperfusion :

- Angioplastie primaire = traitement de CHOIX (revascularisation percutanée sans fibrinolyse préalable, voie radiale → moins d'hémorragies)
- Fibrinolyse (ténecteplase/Metalyse) si angioplastie non accessible dans les délais
- ⚠️ ⚠️ *Ne pas confondre angioplastie primaire (sans fibrinolyse) et angioplastie de sauvetage (après fibrinolyse)*

□ Vu : Mai2024 Q20, Nov2024 Q21, Juin2021 Q4, Mai2020 Q16, Mai19 Q12, Juin19 Q25

Double antiagrégation (doses de charge — piège chiffré) :

- Si ANGIOPLASTIE primaire : Aspirine 250 mg + Clopidogrel 600 mg (ou ticagrelor 180 mg / prasugrel 60 mg)
- Si FIBRINOLYSE : Aspirine 250 mg + Clopidogrel 300 mg (charge réduite, ≤75 ans)
- + anticoagulant (HBPM/enoxaparine) ; prévention secondaire = bithérapie antiplaquettaire ~12 mois

- **⚠ ⚠ Mémoriser : angioplastie → clopidogrel 600 ; fibrinolyse → clopidogrel 300**
- **⚠ ⚠ Aspirine 250 mg (pas 1 g) dans ce contexte**

□ Vu : Mai2024 Q19, Juin2024 Q21, Nov2024 Q20, Ratt2025 Q20, Mai2021 Q14

[RANG 7] MALADIE VEINEUSE THROMBO-EMBOLIQUE (TVP / EP)

— • ~2.47 Q/examen

TVP — clinique & physiopathologie :

- Triade de Virchow : stase veineuse + hypercoagulabilité + lésion pariétale
- Œdème inflammatoire blanc, chaud, DUR, ne prenant pas le godet ; signe de Homans = douleur à la dorsiflexion du pied
- Phlébite bleue (phlegmatia caerulea) = membre gros, FROID, cyanosé (forme grave, ischémique)
- **⚠ ⚠ Homans = dorsiflexion (pas palpation du mollet)**
- **⚠ ⚠ Œdème de TVP ne prend PAS le godet**

□ Vu : Nov2024 Q9, Juin2023 Q9, Mai2022 Q10, Mai2021 Q18, Mai2024 Q8

Stratégie diagnostique (D-dimères / angioscanner) :

- Probabilité FAIBLE + D-dimères NÉGATIFS → diagnostic EXCLU (pas d'imagerie)
- D-dimères POSITIFS → confirmer : angioscanner thoracique (EP) / écho-doppler veineux (TVP)
- EP à HAUT risque (choc/instabilité) sans angioscanner disponible → ÉCHOCARDIOGRAPHIE en urgence (cœur pulmonaire aigu)
- **⚠ ⚠ D-dimères positifs ne CONFIRMENT pas (faible spécificité) — toujours imager**
- **⚠ ⚠ Pas de D-dimères si haute probabilité/instabilité — on impose l'imagerie/ETT**

□ Vu : Mai2024 Q9, Juin2024 Q9-10, Mai2023 Q11, Juin2023 Q10, Mai2022 Q11

Traitement & durée :

- AOD seul d'emblée possible (apixaban, rivaroxaban) ; AVK → chevauchement HBPM ≥5 j jusqu'à INR 2-3 (sur 48 h)
- Durée : facteur transitoire (chirurgie, plâtre) = 3 mois ; idiopathique = ≥ 6 mois ; récidivante / FdR persistant = à vie
- **⚠ ⚠ AVK jamais en monothérapie initiale (relais avec HBPM)**
- **⚠ ⚠ TVP provoquée 3 mois ≠ idiopathique 6 mois ≠ récidivante à vie**

□ Vu : Mai2024 Q10, Nov2024 Q10, Mai2022 Q12, Mai2021 Q19, Mai19 Q40, Juin19 Q39

[RANG 8] ATHÉROSCLÉROSE

— • ~2.13 Q/examen

Plaque vulnérable & complications :

- Plaque vulnérable = chape fibreuse FINE + gros corps lipidique + inflammation → molle, non calcifiée
- Mécanisme clé des complications aiguës = rupture de plaque → THROMBOSE
- Complications : IDM, AVC ischémique, AOMI (pas l'ulcère veineux ni l'AVC hémorragique)
- **⚠ ⚠ Plaque calcifiée/à chape épaisse = STABLE (le faux fréquent)**
- **⚠ ⚠ Complication = AVC ISCHÉMIQUE (pas hémorragique)**

□ Vu : Juin2025 Q31, Ratt2025 Q32-33, Mai19 Q3, Juin19 Q17/Q26, Juin2020 Q23

Maladie systémique & dépistage croisé :

- Une localisation impose la recherche des autres : coronaropathie ↔ AOMI ↔ sténose carotidienne
- Patient coronarien/artéritique = RCV (très) élevé d'emblée
- **⚠ ⚠ Sténose carotidienne → chercher coronaropathie/AOMI (pas anévrisme cérébral ni TVP)**

□ Vu : Mai2024 Q31, Juin2024 Q30-31, Nov2024 Q30-31, Mai2023 Q30-31, Juin2021 Q33

Hypercholestérolémie familiale & cibles LDL :

- HF évoquée si LDL > 1,90 g/l + xanthomes tendineux (± hérédité, sujet jeune)
- Cible LDL chez le coronarien (très haut risque) : < 0,7 g/l (et baisse ≥50 %)
- ⚠️ *Cible coronarien = < 0,70 g/l (pas 1,3 ni 1,6)*

□ Vu : Juin2024 Q32, Nov2024 Q32, Mai2024 Q33, Mai2020 Q4, Juin2021 Q35, Mai2021 Q35

[RANG 9] RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU

— • ~2.00 Q/examen

Étiologie & critères de Jones :

- Streptocoque β-hémolytique du groupe A + terrain (bas niveau socio-économique, génétique)
- Critères MAJEURS : cardite, polyarthrite, chorée, érythème marginé, nodules de Meynet ; MINEURS : fièvre, arthralgies, VS/CRP élevées, PR allongé
- Diagnostic : 2 majeurs OU 1 majeur + 2 mineurs + preuve d'infection streptococcique (ASLO)
- ⚠️ *Compter rigoureusement (ex. polyarthrite = 1 majeur ; PR allongé = 1 mineur)*
- ⚠️ *Nodules de Meynet = sous-cutanés indolores, mobiles, surfaces d'extension (critère MAJEUR)*

□ Vu : Mai2024 Q1-2, Juin2024 Q1, Juin2025 Q1-2, Déc2024 Q1, Ratt2025 Q1

Traitement & prophylaxie :

- Sans cardite : aspirine ; AVEC cardite sévère : corticothérapie (prednisone), au long cours dans les formes sévères
- Prophylaxie secondaire des rechutes : benzathine-pénicilline (Extencilline) IM toutes les 3 semaines, durée selon l'atteinte (jusqu'à 21 ans / 5 ans / à vie si cardite)
- ⚠️ *Corticothérapie réservée à la cardite ; l'aspirine suffit dans l'arthrite sans cardite*

□ Vu : Nov2024 Q1-2, Juin2024 Q2, Ratt2025 Q2, Déc2024 Q2

[RANG 10] ANGOR CHRONIQUE STABLE (SCC)

— • ~2.00 Q/examen

Diagnostic :

- Douleur rétrosternale constrictive, à l'effort, cédant au repos/trinitrine, irradiant mâchoire/membre sup. gauche
- Confirmation par test d'ischémie : écho de stress, scintigraphie myocardique d'effort, ECG d'effort
- Cascade ischémique : métabolique (lactates) → diastolique → systolique → ECG (ST/T) → douleur
- ⚠️ *Angor de novo (<1 mois) = forme instable, pas stable*
- ⚠️ *L'HTA ne fait pas partie de la cascade ischémique*

□ Vu : Mai2023 Q17-18, Juin2023 Q17, Mai2022 Q20, Mai2021 Q11-12, Mai19 Q10-11

Traitement médical optimal :

- Association : Aspirine + bêta-bloquant + IEC + STATINE (prévention + anti-ischémique)
- Dépistage de l'athérosclérose infraclinique : score calcique coronaire
- ⚠️ *Pas d'anticoagulant (AVK/AOD) ni de double antiagrégation systématique dans l'angor stable non revascularisé*

□ Vu : Juin2023 Q18, Mai2022 Q21, Juin2021 Q6-7

[RANG 11] MALADIE DU PÉRICARDE (aiguë, constrictive, tamponnade)

— • ~2.00 Q/examen

Péricardite aiguë — diagnostic :

- Douleur thoracique positionnelle (majorée à l'inspiration et en décubitus, soulagée penché en avant)
- Frottement péricardique : méso-cardiaque, superficiel, systolo-diastolique, en « cuir neuf », variable, PERSISTE en apnée
- ECG (stades de Holzman) : I = sus-décalage ST DIFFUS CONCAVE vers le haut, sans miroir ; II = ondes T plates ; III = T négatives symétriques ; IV = normalisation ; sous-décalage du PQ
- Forme virale du sujet jeune : début brutal, évolution rapide bénigne
- ⚠️ ⚠️ *Sus-décalage CONCAVE diffus SANS image en miroir (≠ SCA ST+ convexe localisé)*
- ⚠️ ⚠️ *L'absence de frottement n'élimine PAS le diagnostic ; biopsie non indispensable*

□ Vu : Mai2022 Q22-23, Mai2021 Q1-2, Mai2023 Q15-16, Juin2023 Q16, Ratt2025 Q22

Traitement de la péricardite aiguë idiopathique/virale :

- AINS (aspirine 1 g ×3/j ou AINS) + COLCHICINE en 1ère intention
- ⚠️ ⚠️ *Pas d'anticoagulant (risque hémorragique péricardique) ; corticoïdes en 2e ligne seulement*

□ Vu : Juin2025 Q21, Mai2023 Q16, Mai2022 Q24, Mai19 Q2

Tamponnade :

- Adiestolie AIGÜE : assourdissement des bruits, signes d'insuffisance cardiaque droite aiguë, pouls paradoxal, choc
- Traitement en état de choc : drainage / ponction péricardique écho-guidée EN URGENCE
- ⚠️ ⚠️ *Tamponnade = adiestolie aiguë (pas chronique), ne donne pas d'HTA ni de pouls bondissant*
- ⚠️ ⚠️ *En état de choc : drainage immédiat (pas d'AINS/anticoagulants)*

□ Vu : Juin2023 Q15, Mai2020 Q18, Juin19 Q27, Ratt2025 Q21 (inclassifiable fusionnée)

Péricardite chronique constrictive :

- Étiologie la plus fréquente (notre contexte) : TUBERCULEUSE
- Tableau d'insuffisance cardiaque DROITE ; confirmation : aspect « dip-plateau » au cathétérisme droit
- ⚠️ ⚠️ *Ne donne pas d'HTP précapillaire isolée ni de cirrhose directe ; le dip-plateau est la clé*

□ Vu : Juin2025 Q22, Mai2020 Q19, Mai2021 Q4, Mai19 Q13

[RANG 12] ENDOCARDITES INFECTIEUSES

— • ~1.73 Q/examen

Porte d'entrée → germe :

- Bucco-dentaire → streptocoque NON groupable (viridans, α-hémolytique)
- Cutanée / toxicomanie / cathéter → STAPHYLOCOQUE
- Sur prothèse < 1 an = endocardite PRÉCOCE (souvent staph) ; > 1 an = tardive
- ⚠️ ⚠️ *Streptocoque α-hémolytique NON groupable (viridans) — pas le β-hémolytique du groupe A (= RAA)*

□ Vu : Juin2025 Q3, Mai2024 Q3, Mai2023 Q3, Mai19 Q30, Déc2024 Q3

Critères de Duke & signes :

- 2 critères MAJEURS suffisent (hémocultures positives typiques + végétations à l'échocardiographie)
- Signes périphériques : faux panaris d'Osler, taches de Janeway, nodules/taches de Roth, purpura
- Antibiothérapie prolongée : 4–6 semaines
- ⚠️ ⚠️ *Hémocultures + + végétations = 2 majeurs → diagnostic certain (rien ne manque)*
- ⚠️ ⚠️ *Nodules de Roth/Osler ≠ nodules de Meynet (RAA)*

□ Vu : Mai2023 Q4, Juin19 Q31, Ratt2025 Q3, Juin2024 Q4, Nov2024 Q4

Antibioprophylaxie & antibiothérapie probabiliste :

- Prophylaxie (cardiopathie à haut risque, soins dentaires) : Amoxicilline 2 g, 1 heure AVANT le geste
- Hémocultures négatives → antibiothérapie probabiliste type Ceftriaxone + pénicilline G (couverture large)

- **⚠️** **⚠️** Prophylaxie = 1 dose AVANT le geste (pas après, pas 8 jours)
- **⚠️** **⚠️** Haut risque = prothèse valvulaire / cardiopathie congénitale cyanogène / ATCD d'endocardite (pas l'âge ni le sexe)

□ Vu : Mai2024 Q4, Juin2024 Q3, Juin19 Q30, Nov2024 Q3

[RANG 13] PROTHÈSES VALVULAIRES CARDIAQUES

— • ~1.73 Q/examen

Mécanique vs biologique :

- MÉCANIQUE : anticoagulation par AVK À VIE, indiquée chez le SUJET JEUNE, risque de thrombose, durée illimitée
- BIOLOGIQUE (bioprothèse) : pas d'anticoagulation au long cours, sujet âgé / désir de grossesse, mais DÉGÉNÈRE avec le temps
- Choix selon : âge, désir de grossesse, FA associée, contre-indication aux AVK, observance
- **⚠️** **⚠️** Mécanique → AVK à vie (jamais AOD) ; biologique → dégénère (durée limitée)
- **⚠️** **⚠️** Le sexe et la localisation ne dictent pas le choix

□ Vu : Juin2025 Q50, Juin2024 Q49, Nov2024 Q49, Mai2023 Q49-50

Greffes valvulaires :

- Homogreffe = valve biologique HUMAINE (cadavérique) ; pas d'anticoagulation ; utile en cas d'endocardite ; peut dégénérer
- Autogreffe = valve/tissu prélevé chez le patient lui-même (ex. intervention de Ross)
- **⚠️** **⚠️** Homogreffe = humaine (pas porcine = hétérogreffe) ; aucune ne « ne dégénère jamais »

□ Vu : Mai2024 Q44, Nov2024 Q50, Juin2025 Q47, Mai2023 Q45

[RANG 14] ANÉVRISME DE L'AORTE ABDOMINALE

— • ~1.67 Q/examen

Définition & terrain :

- Dilatation avec perte de parallélisme des bords, > 3 cm ; siège AORTE SOUS-RÉNALE (le + fréquent des anévrismes artériels)
- Origine athéromateuse ; homme âgé, tabagique ; souvent asymptomatique → découverte fortuite
- Dépistage par ÉCHOGRAPHIE abdominale (homme âgé + FdR CV)
- **⚠️** **⚠️** Dépistage = échographie (pas TDM systématique)
- **⚠️** **⚠️** Sous-rénal (pas sus-rénal) ; rarement symptomatique

□ Vu : Mai2023 Q41, Mai2022 Q42, Juin2021 Q43, Mai2020 Q43, Juin19 Q45

Indications chirurgicales & complications :

- Chirurgie si diamètre ≥ 5 cm (homme) / ~4,5 cm (femme), croissance > 10 mm/an, ou symptomatique
- Rupture = urgence chirurgicale vitale ; peut se révéler par ischémie de membre / signes digestifs
- Traitement médical : antiagrégants + contrôle des FdR (n'réduit pas la taille)
- **⚠️** **⚠️** Seuil chirurgical = 5 cm (pas 30 mm) ; fissuration ≠ traitement médical seul

□ Vu : Mai2023 Q42, Mai2022 Q43, Juin2023 Q42, Déc2024 Q41

[RANG 15] AOMI (artériopathie oblitérante des membres inférieurs)

— • ~1.60 Q/examen

Clinique & diagnostic :

- Localisation athéromateuse fréquente ; tabac = principal FdR modifiable ; diabète → risque élevé d'amputation
- Révélée par claudication intermittente (symptôme le + fréquent) ; abolition des poulx (valeur localisatrice) ; dysfonction érectile si atteinte aorto-iliaque
- Examen de 1ère intention : ÉCHO-DOPPLER artériel ; IPS < 0,9 (l'artériographie n'est pas systématique)
- ⚠️ ⚠️ *Origine ATHÉROMATEUSE (pas inflammatoire) ; coexistence d'autres localisations FRÉQUENTE*
- ⚠️ ⚠️ *Douleur de DÉCUBITUS = ischémie critique (signe de gravité)*

□ Vu : Juin2025 Q46, Mai2024 Q50, Juin2024 Q44, Nov2024 Q43, Mai2023 Q43

Prise en charge :

- Contrôle des FdR + arrêt du tabac (ralentit l'évolution) ; antiagrégant plaquettaire ; réadaptation à la marche chez le claudicant
- Revascularisation (chirurgicale ou endovasculaire) selon le stade ; bons résultats à moyen/long terme
- ⚠️ ⚠️ *L'anticoagulant n'est PAS systématique ; la revascularisation n'est pas TOUJOURS indiquée (claudication = d'abord médical + marche)*

□ Vu : Juin2024 Q45, Nov2024 Q44, Juin2023 Q46, Mai2022 Q46, Juin2020 Q45

[RANG 16] DISSECTION DE L'AORTE

— • ~1.60 Q/examen

Diagnostic :

- Douleur thoracique brutale, intense, déchirante, migratrice (vers le dos) ; asymétrie tensionnelle/des poulx
- Confirmation aux urgences : ANGIOSCANNER thoraco-abdominal (ou ETO) ; radio = élargissement médiastinal (inconstant)
- Classification de Stanford : A = aorte ASCENDANTE ; B = uniquement descendante (au-delà de la sous-clavière gauche)
- ⚠️ ⚠️ *Faire ECG + troponines pour éliminer/associer un SCA avant tout*
- ⚠️ ⚠️ *Élargissement médiastinal n'est PAS constant*

□ Vu : Mai2024 Q41-43, Juin2024 Q50, Nov2024 Q45-46, Ratt2025 Q50, Juin2025 Q49

Traitement selon le type :

- Type A : URGENCE CHIRURGICALE (remplacement prothétique de l'aorte ascendante + fermeture de la porte d'entrée) ; complications : IA aiguë, IDM, tamponnade, rupture
- Type B non compliqué : traitement médical (antalgique + contrôle strict de la PA/FC)
- Mortalité spontanée du type A très élevée (≈1-2 %/heure les premières 24-48 h)
- ⚠️ ⚠️ *Type A = chirurgie (pas endovasculaire seul, pas traitement médical seul)*
- ⚠️ ⚠️ *Antalgique + antihypertenseur ne sont PAS les seules options dans le type A*

□ Vu : Nov2024 Q47, Mai2021 Q44, Juin2021 Q50, Mai2020 Q46, Mai19 Q43

[RANG 17] INSUFFISANCE MITRALE

— • ~1.47 Q/examen

Souffle & retentissement :

- Souffle SYSTOLIQUE à la pointe, doux en « jet de vapeur », irradiant vers l'aisselle, mieux entendu en décubitus latéral GAUCHE
- Retentissement d'AMONT : dilatation de l'OG → HTAP ; d'AVAL : dilatation du VG (surcharge volumétrique)
- ⚠️ ⚠️ *Systolique (pas diastolique) ; « amont » = OG/HTAP, « aval » = VG — bien orienter*

□ Vu : Mai2024 Q7, Juin2024 Q7, Mai2022 Q5, Juin2023 Q7, Juin2025 Q5

IM aiguë :

- Étiologies : IDM avec rupture de pilier, rupture de cordage, endocardite
- Tableau : OAP brutal ; ECG souvent NORMAL (pas le temps de dilater les cavités)
- **⚠ ⚠ IM aiguë → OAP + ECG normal (l'absence d'HVG/HAG n'élimine pas)**
- **⚠ ⚠ Le RAA donne l'IM chronique, pas l'IM aiguë par rupture**

□ Vu : Mai2023 Q6, Mai2022 Q6, Juin2021 Q23, Mai2021 Q24, Mai19 Q34

[RANG 18] VARICES DES MEMBRES INFÉRIEURS

— • ~1.20 Q/examen

Définition & clinique :

- Dilatation permanente des veines SUPERFICIELLES (altération pariétale + incontinence valvulaire)
- FdR : station debout prolongée, sédentarité, grossesse, hérédité ; symptômes peu spécifiques (lourdeurs)
- Examen de 1ère intention : ÉCHO-DOPPLER veineux des 2 MI
- **⚠ ⚠ Signe fonctionnel = lourdeur (PAS la claudication intermittente = AOMI) ; pas d'abolition des poulx**
- **⚠ ⚠ FdR ≠ ceux de l'AOMI (le faux récurrent)**

□ Vu : Juin2025 Q41-42, Mai2024 Q49, Juin2024 Q41, Mai2022 Q44, Mai2020 Q48

Complications & anatomie veineuse :

- Complications : thrombose veineuse superficielle, rupture, ulcère de jambe, dermite ocre (pigmentation = chronicité)
- Réseau profond draine ~90 % du sang du MI ; superficiel ~10 % ; perforantes traversent le fascia (profond↔superficiel) ; communicantes relient 2 veines superficielles
- **⚠ ⚠ Le réseau SUPERFICIEL draine 10 % (pas 90 %)**
- **⚠ ⚠ Perforante = profond↔superficiel ; communicante = superficiel↔superficiel**

□ Vu : Nov2024 Q42, Mai2021 Q45, Mai2020 Q49, Juin19 Q49, Mai19 Q45

[RANG 19] SCA ST- (sans sus-décalage)

— • ~1.13 Q/examen

Définition & évaluation :

- Urgence ; thrombose coronaire aiguë SUB-occlusive (non transmurale)
- Évaluation indispensable : ECG + troponine hypersensible ; stratification du risque ischémique par le score GRACE
- Peut évoluer vers l'occlusion complète (passage en SCA ST+)
- **⚠ ⚠ Score GRACE (ischémique) — pas Genève (EP), pas CHA₂ DS₂ -VASc (FA), pas Wells**
- **⚠ ⚠ THROMBOLYSE CONTRE-INDIQUÉE dans le SCA ST- (à la différence du ST+)**

□ Vu : Mai2024 Q17-18, Juin2024 Q17-18, Nov2024 Q17, Mai2023 Q19, Juin2023 Q19

Traitement :

- Antithrombotique = pierre angulaire : Aspirine + inhibiteur P2Y12 + anticoagulant (enoxaparine)
- Coronarographie ± angioplastie selon le risque : < 2 h si très haut risque ; ≤ 24 h si haut risque
- **⚠ ⚠ Très haut risque → coronarographie < 2 heures**

□ Vu : Juin2024 Q19, Nov2024 Q18, Juin2023 Q20, Juin2025 Q18, Ratt2025 Q18

[RANG 20] ISCHÉMIE AIGUË DES MEMBRES INFÉRIEURS

— • ~1.13 Q/examen

Diagnostic (urgence) :

- Urgence diagnostique ET thérapeutique, pronostic vital et fonctionnel engagés
- Diagnostic CLINIQUE : douleur + impotence + froideur + pâleur + abolition des pouls (± paralysie sensitivomotrice = gravité)
- Cause emboligène fréquente : cardiopathie sous AVK arrêté / FA
- ⚠️ ⚠️ *Diagnostic clinique — ne pas retarder par l'artériographie*
- ⚠️ ⚠️ *Phlyctènes/cyanose marbrée fixe = ischémie dépassée (signe tardif, pas initial)*

□ Vu : Juin2025 Q44, Juin2021 Q48, Juin2020 Q41-42, Mai19 Q46, Juin19 Q41

Traitement :

- Héparinothérapie IV SANS DÉLAI
- Revascularisation : embolectomie à la sonde de Fogarty (artère saine, embolie) ; thrombo-aspiration + traitement de la lésion (artère pathologique)
- Surveiller le syndrome de revascularisation (IRA, hyperkaliémie)
- ⚠️ ⚠️ *Héparine immédiate (pas AVK en urgence) ; amputation = ultime recours*

□ Vu : Ratt2025 Q41, Mai2021 Q49, Juin2021 Q46, Mai2020 Q47, Juin19 Q44

[RANG 21] COARCTATION AORTIQUE

— • ~1.13 Q/examen

Deux formes :

- Nouveau-né : forme GRAVE, tableau d'insuffisance cardiaque (dyspnée), pronostic plus sévère ; circulation collatérale par les artères intercostales
- Grand enfant : souvent fortuite, HTA aux membres SUPÉRIEURS + diminution/abolition des pouls fémoraux, souffle inter-scapulo-vertébral, circulation collatérale (érosions costales)
- Siège isthmique ; souvent associée à une bicuspidie aortique ; confirmation par échocardiographie ; risque d'endocardite
- ⚠️ ⚠️ *HTA aux membres SUP (pas hypotension) ; forme du nouveau-né plus grave que celle du grand enfant*
- ⚠️ ⚠️ *Bicuspidie aortique (pas mitrale) est l'association classique*

□ Vu : Mai2024 Q45, Juin2024 Q46-47, Nov2024 Q48, Mai2023 Q46, Mai19 Q44

Traitement chirurgical & complications :

- Résection-anastomose termino-terminale par thoracotomie postéro-latérale gauche (sans CEC) ou voie endovasculaire
- Complications : recoarctation, hémorragie, ischémie médullaire (paraplégie), chylothorax
- ⚠️ ⚠️ *Pas de CEC pour la coarctation isolée ; traitement non médical seul*

□ Vu : Mai2024 Q46, Mai2023 Q47, Mai2020 Q45, Juin2020 Q44, Juin19 Q46

[RANG 22] INSUFFISANCE AORTIQUE

— • ~1.07 Q/examen

Souffle & signes périphériques :

- Souffle DIASTOLIQUE doux, aspiratif, foyer aortique, irradiant le long du bord sternal gauche ; mieux entendu penché en avant, en expiration forcée
- Élargissement de la différentielle (PA diastolique basse, ex. 130/40) ; signes périphériques : Musset, Durozier, pouls bondissant (hyperpulsatilité)
- ⚠️ ⚠️ *Diastolique (pas systolique) ; PA différentielle ÉLARGIE (≠ pincée du RAo)*
- ⚠️ ⚠️ *Position d'auscultation = penché en avant en EXPIRATION*

□ Vu : Mai2024 Q6, Juin2024 Q6, Nov2024 Q7, Mai2021 Q22, Mai19 Q35

IA aiguë :

- Étiologies aiguës : dissection aortique, endocardite ; tableau d'OAP
- IA chronique sévère : dilatation du VG (surcharge volumétrique)
- ⚠️ *IA aiguë → penser DISSECTION / endocardite (urgence)*

□ Vu : Mai2022 Q9, Juin2020 Q31, Ratt2025 Q8

[RANG 23] RÉTRÉCISSEMENT AORTIQUE

— • ~1.00 Q/examen

Souffle & retentissement :

- Souffle SYSTOLIQUE éjectionnel, rude, râpeux, foyer aortique, irradiant vers les vaisseaux du cou ; abolition de B2 + pincement de la différentielle si serré
- Retentissement d'AMONT = HVG (concentrique) ; d'AVAL = ischémie myocardique (hypoperfusion coronaire malgré coronaires saines)
- Triade symptomatique : angor, syncope d'effort, dyspnée ; serré si surface < 1 cm²
- ⚠️ *« Aval » = ischémie myocardique ; « amont » = HVG (bien distinguer)*
- ⚠️ *L'angor du RAO s'explique par la sténose elle-même (pas obligatoirement une plaque coronaire)*

□ Vu : Mai2024 Q5, Juin2024 Q5, Nov2024 Q6, Juin2020 Q33, Mai19 Q36

[RANG 24] RÉTRÉCISSEMENT MITRAL

— • ~0.80 Q/examen

Auscultation (triade de Duroziez) & retentissement :

- Triade de Duroziez : éclat de B1 + claquement d'OUVERTURE de la mitrale + roulement DIASTOLIQUE (apexien)
- Retentissement d'amont : dilatation OG → cavités droites + HTAP ; FA fréquente ; risque thrombo-embolique
- ECG/Radio : dilatation OG + cavités DROITES (HTAP). Le VG reste NORMAL (non dilaté)
- ⚠️ *Le RM ne dilate PAS le ventricule gauche (la « discordance » classique des QE)*
- ⚠️ *Roulement DIASTOLIQUE (pas systolique) ; claquement d'OUVERTURE*

□ Vu : Juin2025 Q6, Juin2023 Q5-6, Mai2022 Q7, Mai2021 Q21, Juin2020 Q32, Mai19 Q32

[RANG 25] HTAP / HYPERTENSION PULMONAIRE

— • ~0.73 Q/examen

Définitions hémodynamiques :

- HTP = PAPm ≥ 20-25 mmHg (cathétérisme droit)
- PRÉ-capillaire (HTAP groupe 1) : PAPO ≤ 15 mmHg + résistances pulmonaires > 3 UW
- POST-capillaire (groupe 2, cardiopathies gauches) : PAPO > 15 mmHg
- ⚠️ *Pré-capillaire = PAPO basse + RVP élevées ; post-capillaire = PAPO élevée*

□ Vu : Mai2020 Q11, Juin2020 Q11, Mai2021 Q39, Mai2023 Q40

Classification & traitement :

- Groupe 1 (HTAP) ; 2 (cardiopathies gauches) ; 3 (maladies respiratoires/hypoxie) ; 4 (post-embolique) ; 5 (multifactoriel)
- Traitement spécifique de l'HTAP (groupe 1) : antagonistes des récepteurs de l'endothéline, inhibiteurs PDE5 (sildénafil), analogues de la prostacycline
- ⚠️ *Les IEC ne sont PAS le traitement spécifique de l'HTAP groupe 1*

□ Vu : Mai2020 Q9, Juin2020 Q9/Q12, Juin2023 Q40, Mai2021 Q40, Juin2021 Q40

[RANG 26] SYNCOPÉ

— • ~0.53 Q/examen

Stratification du risque :

- HAUT risque : syncope à l'effort ou en décubitus, ATCD de coronaropathie/cardiopathie structurelle, ECG anormal, PAS < 90 mmHg
- BAS risque : longue histoire de syncopes avec prodromes vagues, examen et ECG normaux
- ⚠️ ⚠️ *Syncope à l'effort ou allongée = TOUJOURS haut risque (cause cardiaque)*
- ⚠️ ⚠️ *Prodromes vagues + ECG normal = bas risque (vasovagale)*

□ Vu : Juin2025 Q23, Mai2024 Q23, Juin2024 Q23, Nov2024 Q23

PARTIE 4 — TOPICS HORS LEÇONS OFFICIELLES 2026 (COURS ANNULÉ)

⚠ DISCLAIMER — À LIRE AVANT D'UTILISER CETTE SECTION ⚠

These lessons are NOT in the 2026 exam program.

Cours annulé — NOT officially scheduled.

USE AT YOUR OWN RISK — BUT GOOD TO KNOW.

Ces topics représentaient historiquement ~0% des questions des examens passés. S'ils ne sont PAS au programme cette année, ils peuvent malgré tout :

- Apparaître en question résiduelle ou rattrapage
- Être recyclés à la dernière minute
- Servir de "culture générale" médicale

(Aucun topic hors programme — tous les topics correspondent aux leçons officielles cette année.)

AIDE-MÉMOIRE FINAL — HIGH-YIELD CONCOURS CARDIOLOGIE & CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE

** SCORES, CLASSIFICATIONS & DÉFINITIONS CHIFFRÉES **

HTA cabinet	G1 140-159/90-99 · G2 160-179/100-109 · G3 ≥180/110
HTA hors cabinet	Auto/MAPA diurne ≥135/85 · 24 h ≥130/80 · nuit ≥120/70
FEVG	Altérée <40 % · intermédiaire 40-49 % · préservée ≥50 %
CHA ₂ DS ₂ -VASc	Anticoagulation FA ; =0 → rien ; ≥1-2 → AOD (AVK si valvulaire)
GRACE	Risque ischémique du SCA ST-
Stanford	A = aorte ascendante (chirurgie) · B = descendante (médical)
Jones	RAA : 2 majeurs OU 1 majeur + 2 mineurs + preuve strepto
Holzman	Péricardite : I sus-ST concave diffus → II T plates → III T négatives → IV normal
AAA	Chirurgie si ≥5 cm (H) / ~4,5 cm (F) ou +10 mm/an
RAo serré	Surface < 1 cm ²

** SOUFFLES & SIGNES CLÉS PAR VALVULOPATHIE **

Marqueur / Critère	Indication
IM	Systolique pointe, jet de vapeur, irradie aisselle, décub. latéral G
RAo	Systolique éjectionnel râpeux, irradie cou, abolition B2, diff. pincée
IA	Diastolique doux aspiratif, penché avant/expiration, diff. élargie, Musset/Durozier
RM	Roulement diastolique + éclat B1 + claquement d'ouverture (triade Durozier)
PCA	Souffle CONTINU sous-claviculaire gauche
CIV	Systolique 4e EICG en rayon de roue
Frottement péricardique	Systolo-diastolique, cuir neuf, persiste en apnée

** PIÈGES CLASSIQUES DU CONCOURS **

- ⚠ Seuil HTA ambulatoire (135/85) ≠ cabinet (140/90) — erreur n°1
- ⚠ Plaque vulnérable = chape FINE + gros cœur lipidique (calcifiée/épaisse = stable)
- ⚠ AOD interdits en FA VALVULAIRE et sur prothèse mécanique → AVK
- ⚠ Thrombolyse interdite dans le SCA ST- (autorisée dans le ST+)
- ⚠ Charge clopidogrel : 600 si angioplastie, 300 si fibrinolyse ; Aspirine 250 mg
- ⚠ Fallot = CIV (pas CIA) + sténose pulmonaire (pas aortique)
- ⚠ CIA → cavités DROITES ; le RM ne dilate PAS le VG

- ⚠ D-dimères positifs ne confirment rien ; négatifs + proba faible = exclut
- ⚠ Réseau veineux superficiel draine ~10 % (pas 90 %)
- ⚠ Dissection type A = chirurgie urgente ; type B non compliqué = médical
- ⚠ Tamponnade = adiestolie AIGUË → drainage (jamais d'anticoagulant)
- ⚠ Streptocoque viridans (non groupable) = endocardite bucco-dentaire ; groupe A = RAA
- ⚠ Prophylaxie endocardite = amoxicilline 2 g 1 h AVANT le geste

**** CASCADES & ARBRES DÉCISIONNELS ****

- Plaque rompue → thrombose → occlusion complète (ST+) / sub-occlusive (ST-)
- Cascade ischémique : métabolique → diastolique → systolique → ECG (ST/T) → douleur
- EP suspectée : proba faible + D-dimères - → STOP ; sinon angioscanner (ETT si choc)
- BAV complet : réversible → SEES + cause ; dégénératif → pacemaker double chambre définitif
- TGV : + CIV large → cure d'emblée ; isolée → Rashkind urgent ± prostaglandine
- Ischémie aiguë MI : héparine immédiate → Fogarty (artère saine) / thrombo-aspiration (artère malade)
- RAA récidive : Extencilline IM / 3 semaines (durée selon cardite)

Généré par Claude.ai (claude-opus-4-8) — Version 1
 Cross-match 750 QEs officielles × Cours AIO Cardio-Ccv (cardio-aio.pdf)
FMPM — Pathologie cardiovasculaire S6 — Concours 2026

Améliorations Version 1 :

- ✓ PARTIE 3 strictement par rang (1 → 26)
- ✓ 750 QE / 15 sessions (Mai 2019 → Ratt 2025) ; 650 corrections officielles intégrées
- ✓ Déduplication : 1 entrée/concept avec FAUX explicites (⚠)
- ✓ 3 questions inclassifiables (coroscanner, tamponnade, frottement) fusionnées dans péricardite/angor
- ✓ Topics mappés 1:1 sur la liste officielle S6 — matcher flou bypassé (haute fidélité)
- ✓ Clés discutables signalées (anticoagulation FA / DFG)
- ✓ PARTIE 4 vide : aucune liste officielle de cours annulés 2026 fournie
- ✓ Liens cours par leçon : en attente de la liste officielle des URL FMPM